

LUMINAR SAÚDE | Medicina Respiratória & Terapias do Sono

LAUDO DE POLISSONOGRAFIA NOTURNA COM TITULAÇÃO DE CPAP — Exame Diagnóstico

Computadorizado de Sono

Médico Responsável: Dr. Fernando Albuquerque

CRM: CRM-SP 142.890

Especialidade: Pneumologia

Centro Diagnóstico: Instituto do Sono Luminar - Unidade Jardins

DADOS DO PACIENTE & DADOS CLÍNICOS

Paciente: Luiz Gustavo Moreira	Idade: 48 anos (M)
Convênio: Porto Seguro Ouro	Cidade/UF: Curitiba/PR
Diagnóstico: G47.3 - Apneia Obstrutiva Grave Posicional	Data do Exame: 2026-08-24

PARÂMETROS POLISSONOGRÁFICOS & TITULAÇÃO

Parâmetro Avaliado	Resultado Obtido	Valor de Referência	Interpretação Clínica
Índice de Apneia/Hipopneia (IAH)	32.1 eventos/hora	< 5 /h (Normal)	Grave (Acurado)
Saturação O2 Mínima (SpO2)	79.0 %	> 90 %	Hipoxemia Severa
Saturação O2 Média	92.0 %	> 95 %	Abaixo do normal
Pressão Titulada Recomendada	10.5 cmH2O	Individual	Pressão Ótima
Padrão Respiratório	Nasal	Nasal	Normal
Intensidade do Ronco	Alto	Ausente	Frequente e audível

DISCUSSÃO CLÍNICA & RECOMENDAÇÃO TERAPÊUTICA

Paciente de 48 anos, encaminhado com histórico de sonolência diurna excessiva, roncos frequentes e paradas respiratórias observadas pelo cônjuge. Apresenta comorbidades: Diabetes Tipo 2, Refluxo Gastroesofágico.

A polissonografia noturna demonstrou arquitetura do sono fragmentada, com predomínio de sono superficial e supressão de sono REM. Foram registrados múltiplos eventos obstrutivos resultando em IAH de 32.1 ev/h com queda acentuada de saturação para 79.0%.

Durante a segunda metade da noite (titulação pressórica com CPAP Auto), obteve-se abolição completa dos roncos e normalização do índice respiratório na pressão de 10.5 cmH2O.

CONDUTA MÉDICA & PRESCRIÇÃO

Conduta: Indicação formal de terapia com Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas (CPAP/BiPAP)

Tipo de Equipamento Prescrito: CPAP Automático com alívio expiratório (AutoSet / EPR) ou BiPAP em caso de alta resistência.

Interface / Máscara Recomendada: Máscara Nasal compacta ou Almofadas Nasais.

Acessórios / Umidificação: Umidificador aquecido obrigatório para proteção de mucosa e tubo com controle de temperatura.

Acompanhamento: Reavaliação clínica com relatório de adesão e eficácia do telemonitoramento (AirView) em 30 dias.

Dr. Fernando Albuquerque
CRM-SP 142.890 — Pneumologia